

Equipo Interdisciplinario de Mielomeningocele
Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas



Mi bebé nació con Mielomeningocele

Preguntas y respuestas prácticas





Mi bebé nació con Mielomeningocele

Preguntas y respuestas prácticas

Equipo Interdisciplinario de Mielomeningocele
Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas

Mi bebé nació con Mielomeningocele

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PRÁCTICAS

Presentación

Esta nueva edición de nuestro libro es la actualización de una obra publicada originalmente en el año 2007. Aquellos profesionales que participaron en la primera edición fueron pioneros en el acompañamiento de los pacientes que presentan esta condición. A ellos, nuestro más profundo reconocimiento por su compromiso, dedicación y por habernos abierto el camino que hoy continuamos recorriendo.

Desde nuestro presente, asumimos con orgullo el desafío de renovar y ampliar esta propuesta, fruto del trabajo y la entrega de todos los integrantes del equipo médico interdisciplinario de Mielomeningocele del Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas.

Idea original

Dra. Graciela Moucepico

*Ex Jefa del Servicio de Medicina
Física y Rehabilitación*

Equipo actuante

Dra. Nancy Estefanía Bravo

Fisiatría

Dra. Paula Carlopio

Nefrología Pediátrica

Dr. Julio Centurión

Urología Pediátrica

Lic. Samanta Fernandez

Terapia Ocupacional

Dra. Adriana Oviedo

Gastroenterología Pediátrica

Dra. Mercedes Roccatagliata

Pediatría

Dra. Andrea Uez Pata

Neurocirugía

2025

**Consultorio Interdisciplinario
de Mielomeningoceles**

Días de atención

Miércoles de 8 a 12 h

Planta Baja Sector F

Consultorio 30

Turnos presenciales

Av. Illia y Marconi

El Palomar, Morón, Bs. As.

Tel. 4469-9300/9200

PRÓLOGO

La presente edición ha sido elaborada con el propósito de acercar información clara, accesible y actualizada sobre mielomeningocele, su tratamiento y sus implicancias en la vida cotidiana.

Está destinada a toda persona que desee comprender mejor esta condición: madres, padres, abuelos, hermanos, docentes, tutores y, por supuesto, los propios pacientes. Nuestro objetivo es ofrecer una herramienta de orientación que contribuya a despejar dudas, promover la reflexión y fomentar el diálogo con el equipo de salud.

Confiamos en que una mayor comprensión de la enfermedad permitirá disminuir temores y fortalecer el acompañamiento, favoreciendo un abordaje más humano e integral.

Agradecimientos:

**A nuestros pacientes y a sus familias,
quienes con su fortaleza, confianza
y enseñanza cotidiana nos inspiran a
mejorar cada día.**

Edición 2025

**Equipo Interdisciplinario
de Mielomeningocele**

Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas



Preguntas frecuentes

1. ¿Qué es la espina bífida?

Llamamos espina bífida, más conocida como mielomeningocele, a los defectos que involucran el cierre insuficiente del tubo neural a nivel de la columna. El Mielomeningocele (MMC) es una de las formas clínicas más frecuentes.

Se trata de una malformación del sistema nervioso central de origen congénito, ocurre tempranamente en el embarazo durante la 3era y 4ta semana de gestación. Puede ubicarse en la columna cervical, dorsal o lumbar.

Denominamos Meningocele cuando el saco contiene únicamente líquido cefalorraquídeo y meninges, la médula y las raíces están ubicadas dentro del canal medular y mielomeningocele cuando el saco contiene líquido, meninges, médula espinal y raíces nerviosas.

2. ¿Cuál es la causa?

Si bien no se conoce, se cree que es multifactorial por la combinación de algunos factores ambientales o genéticos. Hay factores de riesgo asociados con esta patología como deficiencia de ácido fólico, síndromes genéticos, diabetes, obesidad, algunos fármacos como los anticonvulsivantes.

3. ¿Cómo podemos reducir los riesgos de que ocurra esta enfermedad?

Podemos prevenirla con la suplementación de ácido fólico, con una alimentación variada y también las mujeres en edad fértil pueden tomar un comprimido de ácido fólico de 0.4 mg desde al menos un mes antes de quedar embarazadas hasta el final del primer trimestre.

4. ¿Cuándo se detecta que un bebé tiene mielomeningocele?

El diagnóstico, en la actualidad, se realiza en el embarazo, a través de las ecografías prenatales, generalmente entre las semanas 18 y 21 de gestación. Si las ecografías son sospechosas, se pueden realizar estudios de laboratorio pero la ecografía prenatal es la forma más precisa de diagnóstico.

5. ¿Qué es el ácido fólico?

El ácido fólico es una vitamina que se encuentra en el brócoli, espinaca, jugo de naranja, legumbres, pollo, y en forma sintética en el pan y cereales fortificados.

El ácido fólico es necesario para la producción de glóbulos rojos y la formación del tubo neural.



PEDIATRÍA

Dra. Mercedes Roccatagliata MN 158.181



6. ¿Qué médico realiza los controles de salud de mi bebe?

Como todo bebé, debe tener un médico pediatra de cabecera, quien será un pilar fundamental para garantizar el bienestar del niño. El pediatra además conoce esta afección y sus características. Es posible que los controles sean más frecuentes de acuerdo a la edad del niño y a las necesidades de su familia.

De todas maneras, es importante recordar que el seguimiento debe ser constante y con un equipo interdisciplinario para acompañar esta condición.

7. ¿Cuándo debo vacunar a mi bebé?

El plan de vacunación debe ser completo y bajo el estricto control del pediatra, como en todos los niños y niñas.

8. ¿Cómo debo alimentar a mi bebe?

La mejor alimentación en el primer año de vida es la leche materna.

En los niños con tendencia a la constipación es fundamental la alimentación a pecho ya que ayuda a disminuir la consistencia de la materia fecal.

El inicio de la alimentación complementaria será indicado por el pediatra de acuerdo con cada caso. Si su madurez neurológica lo permite, comenzará con alimentación semisólida a partir de los seis meses.

9. ¿Por qué mi bebé puede tener constipación?

La lesión de la columna ocasiona que los nervios que inervan el intestino funcionen de forma irregular, se llama intestino neurogénico.

Es importante recordar que, si con la alimentación adecuada a las características del niño no se logra evacuar diariamente debemos consultar con Gastroenterología.

10.

¿Puede ocurrir que mi hijo tenga fracturas sin haberse golpeado?

Sí, los niños con mielomeningocele tienen los huesos más frágiles, en especial los niños y adolescentes que tienen lesión a nivel de la columna dorsal y que se desplazan en silla de ruedas.

La fractura se ve como un enrojecimiento de la zona, el brazo o la pierna; por ejemplo, están hinchados y calientes. Muchas veces los niños no sienten dolor. Hay que consultar al equipo médico si se sospecha una fractura, sacar radiografías y tratarlas.

11. ¿Puede mi hijo realizar actividad física?

Sí, es muy beneficioso que se estimule la actividad física, aún en silla de ruedas o con ortesis. La actividad física regular adaptada a las capacidades del niño lo ayudarán a controlar el cuerpo, socializar y mejorar su calidad de vida en general. El ejercicio, sumado a una alimentación adecuada, ayudará a prevenir la obesidad, muy asociada a esta condición.

12. ¿Cómo hay que cuidar la piel?

Los niños pueden presentar alteración de la sensibilidad y dificultades para distinguir los distintos grados de temperatura.

Por lo tanto, es importante:

- Cuidar la temperatura del agua del baño diario.
- Evitar colocar elementos calientes en la cama como bolsa de agua caliente, etc.
- Evitar acercar los pies a la estufa.
- Es importante la higiene de uñas y corte para prevenir hongos.

Prestar atención especial en:

- Ropa ajustada y elásticos.
- El uso de las ortesis que puedan presionar.
- Los apoyos en las prominencias de la columna.
- Rozamiento cuando se desplazan en el piso.
- Lesiones por el uso del pañal.



NEUROCIRUGÍA

Dra. Andrea Uez Pata MN 96.207

13. ¿Puede mi hijo tener un desarrollo puberal prematuro?

Sí, en los niños con mielomeningocele e hidrocefalia puede ocurrir desarrollo puberal precoz. Si el niño tiene vello axilar o pubiano o aumento del tamaño de las mamas, se debe consultar con el pediatra de cabecera, quien evaluará la necesidad de interconsulta a un especialista en Endocrinología.

14.

¿A qué edad se le puede enseñar a realizar el autocateterismo limpio?

El autocateterismo forma parte de los hábitos diarios, como también la alimentación, el vestido e higiene. Lograr la independencia en estos hábitos es clave para la autonomía a futuro. Sugerimos ir logrando paulatinamente dichos hábitos en el transcurso de la escuela primaria.



15. ¿Por qué operaron a mi bebé a pocas horas de nacer?

Los niños con espina bífida a menudo requieren cirugía después del nacimiento para cerrar la abertura de la columna vertebral.

Esto se hace lo más pronto posible para proteger la médula espinal y prevenir infecciones.

16. ¿Qué es la hidrocefalia?

La hidrocefalia es común en los niños con mielomeningocele: hay un exceso de líquido cefalorraquídeo, el cual se acumula en el cerebro y puede ejercer presión sobre los tejidos cerebrales. Puede presentarse los días siguientes al cierre del defecto, requiere la colocación de una válvula de derivación para drenar el líquido hacia otra parte del cuerpo, como el abdomen.

17. ¿Cuándo se opera la hidrocefalia?

Esta condición requiere tratamiento cuando el bebé presenta síntomas como irritabilidad, crecimiento acelerado del tamaño de su cabecita, y cuando en las ecografías se observa aumento del volumen ventricular, por lo que precisa la colocación de una válvula. El niño que tiene una válvula colocada no siente dolor y puede hacer la vida normal de cualquier niño de su edad.

18. ¿Cada cuánto debe ser controlado por neurocirugía?

Al comienzo el seguimiento es más cercano, cada 3 semanas para evaluar la cicatrización de las heridas y el correcto funcionamiento de la válvula. Posteriormente, se van alejando los controles cada 6 meses y luego anuales hasta su adolescencia.

19. ¿Las válvulas pueden dañarse?

Sí, aunque las válvulas son una solución común también existen riesgos de mal funcionamiento, obstrucción o infección. Los síntomas como cefalea, vómitos, irritabilidad, convulsiones o cambios en su estado de conciencia pueden ser sugestivos de disfunción valvular.

En este caso, es necesario consultar con Neurocirugía.



20. ¿Qué estudios hay que realizar?

Durante el seguimiento de estos pacientes los estudios de imágenes como resonancias y tomografías serán necesarios para identificar posibles complicaciones.

21. ¿Qué es el síndrome de Arnold Chiari tipo II?

Es una condición que se asocia a la espina bífida, la parte posterior de la cabeza es más pequeña y las amígdalas cerebelosas se ubican más bajas de lo normal, ocupando la parte superior de la columna cervical. Puede ocasionar ronquidos, trastornos respiratorios y digestivos. Es probable que requiera cirugía para mejorar estos síntomas. Previamente se debe corroborar que la válvula de derivación de líquido esté funcionando correctamente.

22. ¿Qué es la médula anclada?

Es una fibrosis que ocurre en la reparación de la espina bífida, los nervios se adhieren a la duramadre y pueden dar síntomas como dolor de espalda, infección urinaria y cambios en el tono muscular de las piernas. Es posible que requiera una nueva cirugía para liberar la zona.

23. ¿Qué avances hay en estos temas?

En los últimos años, se han realizado múltiples avances en el área de la cirugía fetal.

En algunos casos, cuando se detecta la espina bífida tempranamente en el embarazo, es posible corregir el defecto intraútero. Esta innovadora cirugía no cura la espina bífida, pero puede mejorar el pronóstico funcional de estos pacientes.



En relación con el manejo de la hidrocefalia, también hay algunos avances, como válvulas programables, que permiten ajustar la presión de drenaje sin necesidad de cirugía adicional. También procedimientos alternativos como la ventriculostomía endoscópica, que permite derivar internamente el líquido sin necesidad de válvula.

UROLOGÍA PEDIÁTRICA

Dr. Julio Centurión MN 133.316

24. Me sugiere el pediatra que consulte con el Urólogo infantil, ¿por qué?

El urólogo infantil es el médico especialista en todo lo relacionado con órganos genitales y urinarios de los pacientes pediátricos. Tiene el objetivo de cuidar, preservar la salud renal, tratar las enfermedades urológicas y detectar situaciones de riesgo ya sea del riñón o la vejiga.

La consulta y el seguimiento deben ser constantes y permanentes. Los pacientes que presenten antecedentes de mielomeningocele o lesiones en la médula espinal tendrán siempre algún grado de mal funcionamiento de su vejiga, pudiendo presentar serias consecuencias. Y este es el desafío de mayor importancia: detectar vejigas de riesgo para los riñones.

Hay 2 tipos de vejigas:

- Las vejigas que acumulan orina porque no pueden ser vaciadas espontáneamente. Ese residuo de orina en la vejiga provoca el aumento de la presión en el interior de esta que, a su vez, puede ocasionar reflujo vesicoureteral o una infección urinaria.

- Las vejigas que no pueden almacenar la orina, por lo que hay pérdida de orina o incontinencia urinaria constantemente.

a. Riñones: filtran los desechos tóxicos transportados por la sangre y los transforman en orina.

b. Uréteres: transportan la orina desde los riñones hasta la vejiga.

c. Vejiga: órgano que sirve como reservorio de la orina y que se vacía con cada micción o cateterismo.

d. Esfínter uretral: controla la eliminación o retención de la orina.

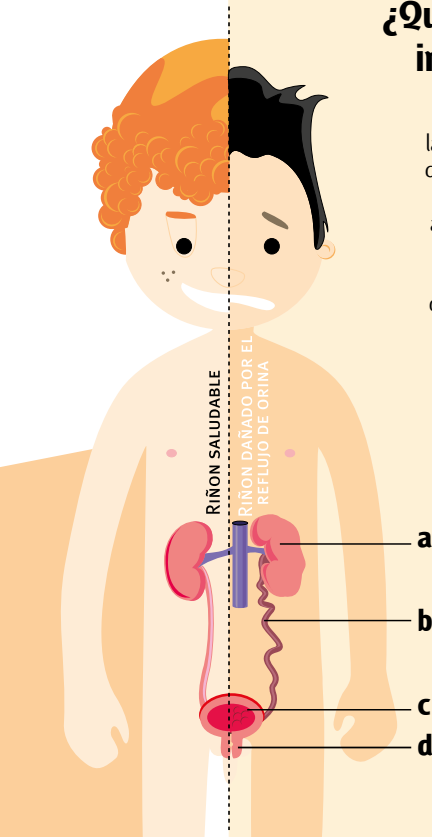
25. ¿Qué es el cateterismo intermitente limpio?

Es un procedimiento para vaciar la vejiga. Consiste en la inserción de una sonda tipo catéter, limpio o incluso estéril, de tamaño adecuado a la edad y textura del paciente, introducido por la uretra hasta la vejiga. Una vez que la orina ha sido drenada por completo, se retira el catéter.

Este procedimiento se repite a intervalos regulares de tiempo. Hoy en día, toda la evidencia médica indica que este es el mejor método para vaciar la vejiga.

A la hora del vaciado, se debe mantener la zona genital higienizada y las manos correctamente limpias.

Muchas veces se recomienda lubricar la sonda o catéter con gel antes de introducirla.



26. ¿Cada cuánto tiempo se recomienda realizar el cateterismo intermitente limpio (CIL)?

La indicación más común es realizarlo cada 4 horas, salvo durante el sueño nocturno (8 a 9 horas). Puede realizar el cateterismo antes de acostarse e inmediatamente al despertar en la mañana. El niño no debe pasar más de 8 horas sin hacer un cateterismo. En algunos casos, ya habiendo conocido el funcionamiento real de la vejiga, puede ser indicado de otra forma, siempre con supervisión del equipo médico.

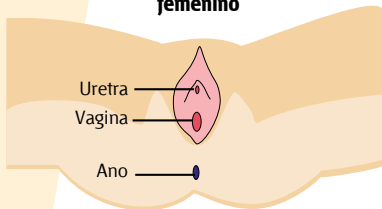
27. ¿Puede lastimarse la uretra al realizarse el cateterismo intermitente limpio?

Sí, es posible. Pero siempre las lesiones serán leves, como inflamación local o sangrado, y en general se solucionan en pocos días sin inconvenientes. De no ser así o para cualquier otro problema, comunicarlo en la consulta médica.

28. ¿Podría mi hijo alguna vez dejar de usar pañales?

Con la técnica y frecuencia adecuada de CIL es posible que los niños y adolescentes estén secos o que la pérdida de orina sea menor. Con paciencia y constancia durante la etapa de la escuela primaria es útil comenzar a enseñar la técnica del autocateterismo, enseñar jugando para que en un futuro lo integren a su vida diaria. Es importante recordar que siempre deben tener el acompañamiento de su especialista, quien indicará los estudios necesarios para evaluar cada etapa.

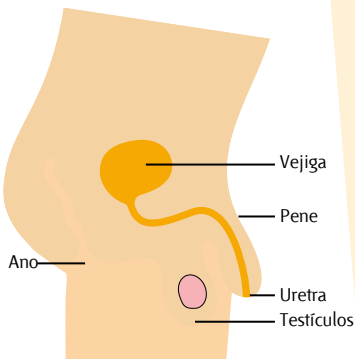
Aparato urinario femenino



29 ■ ¿Qué puede ocurrir si no se realiza el cateterismo intermitente limpio?

El CIL además de asegurar el vaciamiento de la vejiga y bajar la presión de la vejiga, previene la sobrecolonización o infección bacteriana urinaria por orina “estancada”. El CIL previene la pérdida de orina por rebosamiento, como así también el temido reflujo vesicoureteral secundario de orina hacia los riñones, que puede afectar seriamente causando pielonefritis con cicatrices renales irreversibles a futuro.

Aparato urinario masculino



30 ■ ¿Por qué se podría realizar una cirugía de ampliación de la vejiga?

En algunos casos de vejigas de pequeña capacidad para la edad, alta presión vesical de llenado y múltiples infecciones urinarias febriles, que causen daño o cicatrices renales, se puede indicar una cirugía de ampliación vesical.

Esta cirugía consiste en agrandar la capacidad de la vejiga con un segmento de intestino del mismo paciente para anexas a la vejiga y poder tener mayor capacidad de orina, sumando también a que baje la presión intravesical y no la transmita a los riñones.

Esta práctica es un procedimiento programado, que no está exento de complicaciones y requiere un tiempo de adaptación. Requiere una comunicación intensa y fluida con su urólogo de cabecera.

Es importante recordar que, aunque se cuente con ampliación vesical, se deberá seguir realizando el CIL.

31. ¿Existen otros métodos quirúrgicos para tratar continencia y/o vaciado vesical?

Existen otras alternativas, por ejemplo, un dispositivo artificial sintético protésico que se coloca en el cuello de la vejiga como una “bufanda” que impide la pérdida de orina, dando resistencia al mismo. El procedimiento puede realizarse simultáneamente con la ampliación de la vejiga si está indicado, o realizarse solo, si la vejiga tiene suficiente capacidad, pero el niño pierde orina continuamente. Otro ejemplo es un esfínter artificial. Estos métodos solo aseguran la continencia de orina, debe seguir con el CIL.

Es tas situaciones siempre deben ser discutidas con su urólogo, cada paciente y cada situación requiere una evaluación particular.

32. ¿Hasta qué edad es el seguimiento por Urología?

El seguimiento debe ser de por vida, dado las características y comportamiento de las diferentes vejigas neurogénicas resultantes por mielomeningocele.



NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA

Dra. Paula Carlopio MN: 110.343

33. ¿Por qué consultar a Nefrología infantil?

Los niños con MMC o Espina Bífida tienen lesionada la médula espinal por lo tanto los nervios que controlan el llenado y vaciamiento de la vejiga. Este funcionamiento al estar alterado puede tener serias consecuencias sobre la función renal, como dilatación de la vía urinaria por aumento de la presión debido a la acumulación de orina, predisponiendo a infecciones urinarias }reiteradas.

34. ¿Cómo sería el seguimiento por Nefrología?

El rol fundamental del seguimiento por nefrología va a estar dado por monitoreo de la función renal, el cual se va a poder medir en los análisis de sangre mediante la determinación de urea y creatinina.

La estructura, tamaño, características de los riñones y vejiga puede en primera instancia conocerse en la ecografía renal y vesical. Este estudio a lo largo de la vida del paciente nos va a ir brindando información sobre su crecimiento y evolución.

35. ¿Cómo me puedo dar cuenta que mi hijo tiene infección urinaria?

Los síntomas pueden ser fiebre, vómitos, decaimiento, falta de apetito o cambios en las características de la orina (se pueden tornar turbias, malolientes o espesas).

36. ¿Qué pasa si mi hijo tiene muchas infecciones urinarias?

En caso de presentar infecciones urinarias, se realizará el seguimiento de las mismas en cuanto a frecuencia, gérmenes que la ocasionaron, antibióticos utilizados, y requerimiento de internación para realizar tratamiento.

En ocasiones también las infecciones pueden dejar cicatrices en los riñones, las cuales pueden ser documentadas en estudios más complejos.

Algunos pacientes reciben antibiótico todas las noches a modo de intentar prevenir las infecciones urinarias, si bien es muy común esta estrategia se evaluará en cada caso particular.

37. ¿Cada cuánto tengo que llevarlo a los controles?

Dependiendo de la función de los riñones, infecciones urinarias y datos de la Ecografía, se programarán cada 6 meses o 1 año aproximadamente.

38. ¿Hasta qué edad se realizan los controles con Nefrología Infantil?

Los controles son durante toda la vida, debido a que, con el paso de los años, la incidencia de infecciones urinarias, alteración en el vaciado de la vejiga, puede generar cicatrices en los riñones y repercutir en el funcionamiento de los mismos.



GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA

Dra. Adriana Oviedo MN 119.758

39. ¿Mi hijo va a poder dejar los pañales?

Sí, va a depender del nivel de la lesión, severidad medular y si está afectado el esfínter anal, por medio de técnicas, aprendizaje y obturadores anales se puede lograr.

Cada caso es único y es necesario el acompañamiento del equipo médico.

40. ¿Cómo se hace para que deje los pañales?

Un buen momento para comenzar el entrenamiento del intestino es entre los dos a tres años. Habitualmente se logra cierto grado de continencia entre los cuatro y seis años. Se aconseja preguntar al niño si sabe que se hizo encima, si se da cuenta cuando está haciendo. Si es así hay que empezar a llevarlo a la pelela o inodoro, en algunos casos adaptado.

41. ¿Podrá mi hijo controlar esfínteres?

Cada caso es individual y, Sí, es posible. Se debe analizar con Gastroenterología y Pediatría para buscar un tratamiento adecuado para cada niño. En situaciones de incontinencia fecal, existen algunos productos que se pueden utilizar como los tapones anales (anal plugs) de forma temporaria.

42. Mi hijo está estreñado, ¿qué puedo hacer?

Se aconseja que el ritmo de evacuación del intestino sea diario o día por medio.

Para lograrlo, además de aumentar el consumo de agua, es útil incrementar las fibras regularmente en la dieta.

Ofrecer a los niños una dieta variada, incentivar el consumo de verduras de hoja, crudas y/o cocidas, jugos de naranja y ciruela, y salvado de trigo en la preparación de alimentos.

Es importante fomentar los hábitos intestinales, para lograrlo se debe sentar al niño en el baño después del almuerzo y cena. La razón de esta indicación es que todas las personas tenemos un reflejo que se llama gastro-cólico que se produce luego de comer y nos ayuda a evacuar el intestino. El hábito de sentarse en el inodoro a un horario determinado es un refuerzo positivo de este reflejo normal. Cuando el aporte de líquidos y fibra no es suficiente se utilizan laxantes orales.

Si el tratamiento oral falla, hay otras medidas terapéuticas: enemas rectales, irrigaciones transanales. Si a pesar de estas medidas no logran la evacuación intestinal con la evaluación personalizada de su gastroenterólogo, se podría optar por algunas opciones de cirugías como Malone/Chait u ostomías.

43. ¿Qué hay de nuevo en estos temas?

Para manejo de incontinencia fecal o constipación crónica asociada a defecación disinérgica, el tratamiento con Biofeedback anorrectal y Neuroestimulación transcutánea para-sacra es efectivo, es una modalidad segura no invasiva y de bajo costo.

MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

(FISIATRÍA)

Dra. Nancy Estefania Bravo MN 167.497

44. ¿Qué le puede ocurrir al paciente con mielomeningocele?

Cada paciente con espina bífida es diferente, el compromiso en la movilidad y sensibilidad de las piernas va a variar de un caso a otro, dependiendo del lugar de la columna en el cual ocurrió el mielomeningocele.

Las alteraciones en el tono muscular pueden desviar de su posición normal a pies, cadera e incluso a la columna.

El acompañamiento del médico fisiatra es esencial para lograr la mejor calidad de vida de cada paciente ya que es él quien desarrolla un plan integral que busca independencia y funcionalidad a largo plazo.

45. ¿Va a tener dificultad para caminar?

No siempre las personas con espina bífida van a tener dificultades en la marcha, esto depende del nivel en que se encuentre la lesión.

Durante el examen físico es frecuente observar diferentes grados de compromiso motor por debajo del nivel del defecto de la columna, en algunas ocasiones puede ser diferente en cada pierna.

El tratamiento integral de rehabilitación tiene como objetivo incentivar al máximo las capacidades motoras, intelectuales y las psicoafectivas, con el objeto de que el paciente logre la mayor independencia posible en todos los aspectos de su vida.

46. ¿Va a necesitar silla de ruedas?

La necesidad de usar una silla de ruedas va a depender de la gravedad y ubicación del mielomeningocele.

Algunos niños con lesiones altas (las que ocurrieron a nivel torácico) no podrán pararse por sí mismos, necesitarán de diferentes dispositivos de movilidad para mantenerse de pie. En algunas ocasiones, requieren valvas largas y andadores para caminar en el gimnasio o en sus casas y prefieren la silla de ruedas para trasladarse en distancias más largas.

48. ¿Se logra la marcha a la misma edad que otros niños sin MMC?

En los niños con espina bífida, las pautas de desarrollo pueden estar un poco retrasadas por lo que es frecuente que el desarrollo de la marcha sea más tardío. En general, estos chicos logran mantener firme y libre de la cama su cabecita a los tres meses de edad, luego progresivamente van logrando sostén de tronco, el gateo, el arrastre y la posición firme cerca de los 2 años de edad.

Con el fortalecimiento y estimulación ininterrumpida de estas actitudes se logra la marcha entre los dos y cuatro años. Todas estas pautas de maduración motriz se benefician con los constantes tratamientos de rehabilitación.



47. ¿Va a necesitar ayuda para ambular?

Los niños con lesión a nivel lumbar medio pueden caminar con valvas, andadores y/o bastones; son deambuladores domésticos y comunitarios. Los niños con lesión lumbar baja y sacra no necesitan silla de ruedas, solo valvas cortas y/o plantillas.



49. ¿Cuáles son las alteraciones esqueléticas que puede tener?

La debilidad muscular que resulta del mielomeningocele puede ocasionar algunas alteraciones esqueléticas. Las que afectan a la columna pueden cambiar las curvas normales de la espina, son más frecuentes en aquellos defectos ubicados a altura dorsal. Según su desviación, puede ser escoliosis o cifosis.

Los miembros inferiores y la cadera también pueden ser afectados y encontramos que pueden estar luxada una o ambas caderas. Si los niños pasan mucho tiempo sentados sin estirar las rodillas ni la cadera, puede ocurrir fibrosis en las articulaciones, lo que dificulta la correcta alineación de las piernas. Por las mismas razones, los pies pueden estar desviados, lo que se conoce como pie bot. Hay diferentes técnicas para corregirlos, manualmente con el uso de ortesis o hasta correcciones con cirugía.

Para preservar la función y favorecer la independencia es muy útil el equipamiento correcto según la necesidad de cada paciente y el tratamiento continuo de rehabilitación.

50. ¿Hay niños con MMC que pudieran caminar y luego quedar en silla de ruedas?

Un determinado grupo de personas con mielomeningocele puede en un momento de su vida optar por la silla de ruedas para sus movimientos. Las razones de esta situación son múltiples, pueden presentar alteraciones esqueléticas, sobrepeso, aumento del tono muscular - espasticidad que dificulta la marcha y prefieren la silla. La marcha con ortesis o con bastones además de requerir más tiempo para los desplazamientos implica un gran esfuerzo físico para el paciente, por ello algunos optan por favorecer su independencia en la silla de ruedas.

51. ¿Siempre tendrá que realizar tratamientos de rehabilitación?

El objetivo de la rehabilitación es maximizar la independencia y alcanzar el máximo desarrollo posible de la función motora. En la primera infancia es intensiva hasta que comienza la escolaridad. Se trabaja con el objetivo de lograr pautas de desarrollo y mejorar la movilidad, el equilibrio y prevención de complicaciones. Durante la etapa de la escuela primaria, debe ser menos intensa, con el fin de mantener objetivos alcanzados y evitar complicaciones.

Los controles con el médico rehabilitador deben seguir incluso en la edad adulta.

Además de las terapias de rehabilitación, queremos recordar y estimular las actividades recreativas, de vital importancia en la vida de los seres humanos entre las cuales se destaca el deporte adaptado. Estas actividades además de beneficios en el sistema cardiovascular, esquelético y metabólico buscan promover la sociabilización, la integración y el trabajo en equipo.

TERAPIA OCUPACIONAL

Lic. Samanta Fernández MN 1.600

52. ¿Por qué derivaron a mi hijo a Terapia Ocupacional?

La derivación a terapia ocupacional se realiza para que el niño pueda llevar a cabo aquellas tareas que sean apropiadas para su edad de la manera más autónoma posible.

Para esto, el tratamiento trabajará sobre diferentes ejes:

- Brindará estímulos apropiados para la edad, que favorezcan el procesamiento senso-perceptivo, motor y cognitivo, generando así, un ambiente adecuado y favorecedor para el desarrollo de pautas madurativas y de interacción.
- Evaluará los desafíos ocupacionales que pueda manifestar el niño y diseñará junto con él y su familia las ayudas técnicas y las adaptaciones adecuadas para que todas las tareas significativas puedan ser llevadas a cabo con el mayor nivel de autonomía posible.
- Acompañará y asesorará a la familia en el manejo en el hogar para fomentar y sostener hábitos de autonomía en las actividades de autocuidado como alimentación, higiene y vestido desde temprana edad.

53. ¿Por qué es importante que mi hijo tenga autonomía?

La experiencia de participar en tareas que sean significativas para el niño tiene un enorme valor para el desarrollo motor, cognitivo y emocional. Mediante la participación activa en tareas de autocuidado el niño:

- Podrá conocer mejor su cuerpo y cómo funciona: ¿dónde y cómo estoy posicionado? ¿Cómo tengo que moverme para lograr mi objetivo? ¿cómo me voy a manejar en este ambiente? ¿Cuánta fuerza tengo que hacer para mover este objeto?
- Podrá aprender a partir de los diferentes desafíos que se le presenten: para poder aprender a realizar una tarea el niño va a necesitar experimentar, y resolver las dificultades que surjan mediante la experiencia.
- Podrá regular y manejar diferentes emociones: la participación en una tarea pone en juego muchas emociones.

Algunas son satisfactorias y agradables, cuando el niño es exitoso. Otras, son de enojo, frustración. Poder atravesarlas acompañado de un adulto de referencia, ayudará y favorecerá la gestión de las mismas.

- Autoestima: un niño que logra llevar a cabo de manera autónoma las tareas que son relevantes para él, tendrá una imagen de sí mismo positiva y esto generará una mayor autoconfianza.

Los niños nos observan y nos ven llevar a cabo un montón de tareas durante el día. Lo esperado es que deseen imitarnos. Las actividades de la vida diaria son también pautas madurativas que el niño deberá lograr. Dar lugar a la participación en tareas cotidianas favorecerá una buena evolución de todas las áreas de desarrollo.

54. ¿Qué son las actividades de la vida diaria (AVD)?

Las AVD son aquellas actividades que tienen que ver con el cuidado del cuerpo. Las principales actividades de la vida diaria son: alimentación, higiene y vestido. Poder ir adquiriendo autonomía en estas actividades de manera paulatina durante el desarrollo del niño es fundamental para llegar a la vida adulta pudiendo tener un manejo completo de las mismas.



55. ¿A qué edad se comienza a trabajar sobre la independencia en las AVD?

Se comienza desde muy temprana edad. A lo largo del desarrollo el bebé y el niño irán adquiriendo, además de hitos motores, otras pautas que tienen ver con su interacción, su juego, su comprensión.

Las actividades de la vida diaria también se irán desarrollando y el niño va a lograr adquirir cada vez mayor autonomía.

A partir de ver a su familia llevar a cabo estas tareas, su participación en las mismas va a ir aumentando de a poco y sus destrezas para llevarlas a cabo irán también mejorando.

Es por este motivo que facilitar su participación será muy favorecedor para su desarrollo.

56. ¿Todos los niños alcanzan el mismo nivel de independencia en las actividades de la vida diaria?

El nivel de independencia en las actividades de la vida diaria será variable de un niño a otro. Habrá varios factores que estarán relacionados con la autonomía: el nivel de la lesión y la complejidad del cuadro motor, el nivel cognitivo del niño que tendrá impacto no sólo en la función motora sino también en el interés por llevar a cabo estas tareas, el ambiente más o menos favorecedor.

Algunos factores como el sobrepeso, la presencia de deformidades u otras complicaciones asociadas al diagnóstico podrán limitar la movilidad y, por ende, la autonomía.

La Terapia Ocupacional tendrá un rol fundamental en la evaluación funcional del niño y en el planteo de objetivos reales y adecuados de autonomía.

57- ¿Cómo voy a garantizar un ambiente accesible para mi hijo?

Sumado a la estimulación y a las intervenciones terapéuticas se deberá asegurar un ambiente accesible. Esto podrá ser logrado mediante la utilización de adaptaciones y productos de apoyo. Las adaptaciones son modificaciones que se realizan en el entorno, y/o en las actividades favoreciendo que el ambiente sea más amigable y que el nivel de autonomía y funcionalidad sea mayor.

Un ambiente accesible es el que brinda las condiciones necesarias para el desarrollo integral de una persona, permitiendo la expresión auténtica, la movilidad segura y la consolidación de habilidades y competencias, favoreciendo así mayor desarrollo de su autonomía.

Los productos de apoyo son modificaciones que se le harán a los elementos de uso cotidiano para que puedan ser manipulados y usados con mayor precisión y destreza. Los productos de apoyo también son objetos que favorecen la autonomía en las distintas tareas o desafíos que tendrá el niño como los desplazamientos, los alcances, etc.

Algunos ejemplos de adaptaciones y productos de apoyo serán: rampas, barrales, mangos de cubiertos engrosados, etc.

58. ¿Cuándo se suele indicar una Adaptación o Producto de Apoyo?

Las adaptaciones, así como los productos de apoyo serán indicados por diferentes motivos:

- Cuando el niño presenta desafíos en la autonomía que no puedan ser resueltos mediante la terapia, el aprendizaje o los cambios en la rutina.
- Cuando se presenten dificultades en la accesibilidad a un ambiente que amenace su participación en dicho entorno.
- Cuando el niño logre realizar las tareas, pero la manera en las realiza pueda favorecer posiciones viciosas, y/ o deformidades.
- Cuando la manipulación efectiva y el uso de utensilios o herramientas sea dificultosa para el niño.
- Cuando el niño logre llevar a cabo una tarea, pero la misma le requiera de un tiempo excesivo.

59. ¿Las Adaptaciones se usarán toda la vida?

Así como el desarrollo del niño va a ir variando, también cambiarán las necesidades de apoyo que él tenga. De esta manera, de acuerdo a las nuevas etapas que atraviere se podrán ir evaluando los nuevos desafíos y se pensará cuáles adaptaciones seguirán siendo necesarias, cuáles no y si habrá necesidad de sumar otras nuevas.

Las adaptaciones como todos los sistemas de apoyo dependen de la complejidad motora y cognitiva que tenga el niño, así como también del estímulo y el acompañamiento del entorno.



60. ¿Por qué es importante favorecer espacios de juego?

Desde edades tempranas es importante que el niño cuente con un espacio de juego que sea seguro, ya que el juego es una actividad fundamental para el desarrollo.

Mediante esta actividad, los niños aprenden de manera placentera sobre el mundo que los rodea y desarrollan habilidades motoras, de interacción, emocionales y de aprendizaje.

El juego del niño se irá complejizando durante el crecimiento como consecuencia de su experiencia en el entorno y del desarrollo de sus habilidades.

De esta manera, mediante la actividad lúdica, un niño podrá ir mostrando cómo se encuentra procesando el mundo que lo rodea. La repetición de los nuevos logros y el disfrute de esta actividad tan importante son naturales y propios del desarrollo.

El juego es una actividad que necesita de experiencias que involucren distintos sentidos, y la interacción con las personas de apego. Es por este motivo que se desaconseja el uso de pantallas como los celulares, la tablet y demás dispositivos, siendo que la estimulación que recibe un niño por parte de estos elementos no es la adecuada.



61. Si el MMC provoca parálisis y falta de sensibilidad por debajo del nivel de lesión ¿Por qué se trabaja sobre los Miembros Superiores?

Como se dijo anteriormente, existen problemas neuroquirúrgicos y neurológicos (Hidrocefalia, Sdme. de Arnold Chiari, Médula Anclada), que afectan también a los miembros superiores, disminuyendo su funcionalidad.

Maximizar la función de los Miembros Superiores es uno de los objetivos principales del tratamiento de Terapia Ocupacional, ya que la fuerza y coordinación de los brazos serán componentes fundamentales en el desarrollo de las actividades de traslado, en el manejo independiente de los cuidados personales, el autocateterismo, el uso de la silla de ruedas y en el desempeño escolar.

La autonomía de una persona involucra todas las partes del cuerpo. Si bien la funcionalidad de los miembros superiores es una parte importante del tratamiento, el manejo de todo el cuerpo en el ambiente de manera efectiva será el eje para lograr una real independencia.



62. ¿A qué edad es conveniente comenzar con el entrenamiento en el auto-cateterismo?

Esto dependerá de varios factores:

- Del nivel de la lesión y de las habilidades motoras gruesas y finas
- Del nivel cognitivo y de comprensión de la situación
- De las posibilidades de cooperación
- Del grado de conciencia de higiene y seguridad que el niño posea
- Del estado emocional del niño
- De las condiciones del ambiente en el que el niño viva y se realice dicha práctica
- Del interés de la familia

Idealmente el cateterismo se comienza a estimular desde los primeros meses, y en condiciones ideales se espera que el niño pueda llevar a cabo el autocateterismo en la etapa escolar.

63. ¿Cuál es el objetivo final de Terapia Ocupacional como parte de su rehabilitación?

La Terapia Ocupacional tendrá como objetivo brindar las herramientas necesarias para que el niño pueda desempeñarse con la mayor autonomía posible en todas las tareas y actividades que sean relevantes para él o ella y necesarias en sus distintos ciclos vitales. Ésto tendrá un papel fundamental para que pueda construir una imagen de sí mismo satisfactoria, conociendo sus capacidades y limitaciones.

El conocimiento de sí mismo le permitirá elegir conscientemente sus desafíos y desempeñar los distintos roles ocupacionales que se llevan a cabo en una sociedad como ser: estudiante, amigo, trabajador, etc.

La naturaleza ocupacional del ser humano es el eje de ésta disciplina que brindará herramientas al niño para que pueda desempeñarse en la sociedad de acuerdo a sus propios valores e intereses.

TESTIMONIO DE VIDA

**B.G nos cuenta un poco de su vida.
Tiene su seguimiento con el equipo de
nuestro hospital desde que tiene 6 años...**

¡Hola! Soy B, tengo once años y voy a 6to grado turno mañana en la escuela primaria N°28 de José. C Paz. Fui al jardín 914 desde la sala de tres años. Hoy en día curso con varios de mis compañeros de jardín (¡¡¡ya nos egresamos!!!), quienes me cuidan, ayudan y se preocupan por mí.

Quiero contarles que me senté cuando tenía 8 meses, gateé al cumplir 1 año y cuando tenía 1 año y medio comencé a caminar (un gran logro). Siempre me ayudaron y acompañaron para que pueda lograr todo.

Este año comencé a hacer los viajes escolares sola con mis compañeros y mi seño. Me gustan mucho los bebés y los animales. Suelo jugar con los niños más chiquitos. Me gusta también la plaza y jugar con mis peluches.

Cuando sea grande quiero ser TikToker y veterinaria.

**¡¡¡Después del cole
hago mi tarea y después
a jugar!!!**



DIRECCIONES ÚTILES

ANDIS

Agencia Nacional de Discapacidad

Ofrece asesoramiento, actividades deportivas y culturales.

Dirección: Dragones 2201 (CABA).

Correo: deportes@andis.gob.ar

Teléfono: (011) 4789-5254

Atención Temprana del desarrollo infantil

Escuela 505 San Juan de Dios

De 0 a 3 años

Dirección: Barcala 673, Ramos Mejía

Correo: especial505lamatanza@abc.gob.ar

Teléfono: (011) 4654-0673

MI BEBÉ NACIÓ CON MIELOMENINGOCELE

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PRÁCTICAS

2025



Equipo Interdisciplinario de Mielomeningocele
Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas